

补益肾之品,如菟丝子、覆盆子、枸杞子之类,以提高疗效。

4.4 要注意患者排便情况 便秘是慢性前列腺炎的病理结果,也是慢性前列腺炎的诱发和加重的重要因素之一。长期的便秘,强化的排便意识,经常性腹压增高,使腺体更处于充

血状态。因此,有效的解决便秘问题,是提高湿热瘀滞型慢性前列腺炎治愈率的关键之一。方中所用大黄,就是这个意思。

奥美拉唑药物相互作用分析

郭丰 张宝娣 谢丹青

奥美拉唑,别名洛赛克,是一种能够有效地抑制胃酸的分泌的质子泵抑制剂。是近年来研究开发的作用机制不同于 H_2 受体拮抗作用的全新抗消化性溃疡药。它特异性地作用于胃黏膜壁细胞,降低壁细胞中的氢钾 ATP 酶的活性,从而抑制基础胃酸和刺激引起的胃酸分泌。

1 奥美拉唑配伍时对疗效的影响

1.1 与抗菌药物合用 现代医学理论认为,胃酸和幽门螺杆菌(Hp)感染是溃疡病的两大致病因子。由于 Hp 可深藏于腺体隐窝类,单用奥美拉唑或抗菌药物治疗效果都不理想,且 Hp 的根除率不高,常联用克拉霉素、阿莫西林、甲硝唑、替硝唑、呋喃唑酮等。联合治疗 Hp 感染能起到协同作用,增加疗效。

1.2 与维生素合用 奥美拉唑抑制胃酸分泌后,胃内细菌较快生长,菌群发生明显变化,细菌总数增加,致使亚硝酸盐变成有致癌作用的亚硝胺,同时服用维生素 C 或维生素 E 可能有限制亚硝胺化合物形成的作用。长期服用可引起维生素 B₁₂ 的缺乏,维生素 B₁₂ 缺乏可以导致 S 腺苷蛋氨酸和蛋氨酸的合成障碍,很可能是神经系统病变的原因之一。该研究表明这种影响与奥美拉唑剂量有关,剂量越大、影响越大。

1.3 与铁剂、四环素、匹氨西林、酮康唑的合用 铁剂的吸收依赖于胃酸的存在, Fe^{3+} 在胃酸作用下转变为 Fe^{2+} 才被吸收。奥美拉唑抑酸作用影响铁剂的吸收。同时胃酸 pH 升高,使四环素类变成难溶性游离型四环素,不易吸收。匹氨西林是脂化物,只有在酸性环境下吸收完全。酮康唑的吸收也依赖于足够的胃酸分泌因而致使酮康唑的吸收减少。故奥美拉唑与铁剂、四环素、匹氨西林、酮康唑不宜合用。必要时,可适当增加这些药物的剂量。

1.4 与肝药酶代谢有关的药物合用 本品具有酶抑制作用,一些经肝脏细胞色素 P450 系统代谢的药物如双香豆素、华法林、地西洋、苯妥英、硝苯地平,其 $t_{1/2}$ 可因合用而延长,药理作用增强,合用时注意适当减量。

1.5 与地高辛合用 奥美拉唑造成的低酸环境,使地高辛分解为活性较低、药效维持更短的代谢物,降低地高辛治疗作用。服用奥美拉唑及停药后短时间内应调整地高辛剂量。

1.6 与蒙脱石、果胶铋、铝碳酸镁的合用 曹加、胡琴等研究发现蒙脱石(3 g)、果胶铋(150 mg)、铝碳酸镁(500 mg)对奥美拉唑肠溶片和肠溶胶囊平均吸附率分别为 94.94% 和 86.13%、33.96% 和 39.14%、12.46% 和 12.68%。三种药物在体外对奥美拉唑均有不同程度的吸附,建议奥美拉唑口服与肠溶胶囊与这些药物合用时,尽量分开服用,以提高疗效。

1.7 pH 值、光线、金属离子、温度等对奥美拉唑注射液的影响 奥美拉唑为硫酰基苯并咪唑类结构,易受 pH 值、光线、金

属离子、温度等因素的影响。特别是在酸性条件下,奥美拉唑化学结构发生改变,出现聚合和变色现象;在碱性条件下比较稳定。因此说明书上说,溶于 100 ml 生理盐水(pH 4.5~7.0)或 5%糖水(pH 3.2~5.5)中,本品溶解后静脉滴注时间应在 20~30 min 或更长。若使用 250 ml 或 500 ml 输液则配置后 pH 值降低,增加了溶液的不稳定性,且滴注时间延长,易受光线、温度的影响而变色,同时应避免与酸性药物混合滴注;配制所使用的注射器与输液器应单独使用,不直接接触其他药液;本品输液应现用现配,配置好的输液应在 2 h 内用完,在整个静脉滴注过程中应注意避光。

2 奥美拉唑配伍时的药理分析

2.1 奥美拉唑与酮康唑 奥美拉唑是脂溶性弱碱性药物,可能降低咪唑类的生物利用度,减弱其抗真菌作用;咪唑类可能增加质子泵抑制药血药浓度,增强其药理作用。与奥美拉唑联用时,酮康唑的平均 AUC 和血药峰浓度分别降低 64% 和 66%。在其他研究中,与碳酸氢钠联用时,酮康唑的血药浓度也降低。因此,当酮康唑与任何增加胃肠道 pH 值的药物联用时,应考虑可能降低酮康唑的吸收,建议奥美拉唑不与酮康唑同用^[1]。

2.2 奥美拉唑与苯二氮类 奥美拉唑可能升高苯二氮类的血清浓度及药理作用,可能出现毒性反应。因为奥美拉唑可能减弱苯二氮类在肝脏的氧化代谢^[2]。

2.3 奥美拉唑与卡马西平 奥美拉唑可能升高卡马西平的血浆浓度,增强其药理作用。可能出现恶心、嗜睡、眼球震颤、共济失调及其他小脑症状等中毒反应特征。因为奥美拉唑抑制肝微粒体酶,可能减弱卡马西平的代谢清除。

2.4 奥美拉唑与地高辛 因为质子泵抑制药降低胃液酸度,可能减少地高辛水解,增加其吸收。胃液 pH 值 <3 时,地高辛在胃内水解,导致活性降低或丧失。升高胃液 pH 值的因素可能升高地高辛的生物利用度。

2.5 奥美拉唑与甲氨蝶呤(MTX) 由于奥美拉唑抑制氢泵,而 MTX 的肾清除是通过氢离子依赖性机制进行的,因此怀疑 MTX 与奥美拉唑有相互作用,而在第 1 个疗程的第 4 天停用奥美拉唑。在以后 MTX 的 3 个疗程中,MTX 浓度在达到高峰后迅速下降,这与 MTX 的正常药动学相符。应考虑停止奥美拉唑治疗,密切监测血浆 MTX 浓度,并适当地采用亚叶酸解救、充分补液及碱化尿液^[2]。

参考文献

- [1] 容健材,廖锡麟.新编实用药物手册.第一版.南京:东南大学出版社,1996:353.
- [2] 周霞.奥美拉唑与雷尼替丁治疗消化性溃疡疗效观察.中国临床医药研究杂志,2006,154:17-18.